

GUILHERME SOARES CARDOSO DA CUNHA

MEDICAMENTOS:

HAS (atenolol) Adblock?
Palpitação em (D.V)

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRÁTICA EXERCÍCIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

29/06 P = 7,3 média (4-15) cmH₂O

06 IAH = 11,2

22 volume de fuga = 0,0 l/min.

fua

13/07 P = 10,8 cmH₂O

07 IAH = 9,7 l/h

22 m. de uso: 6h30'

Bem adaptado, oriento a adapt. da traqueia

fua

17/08 P = 7 cmH₂O

22 IAH = 10,8 l/h

m. de uso: 4hs

fua

10/07 P = 7 cmH₂O

CPAP SB.

23 m. de uso: 6h25'

CPAP yuwell - P = autom. 5-11 cmH₂O.

IAH = 8,8 l/h

fua

09/08/23 P = 7,5 cmH₂O (fixo)

IAH = 9,3 l/h

m. uso: 6 horas

} yuwell - 18 dias

P = 7,4 cmH₂O fixo

tempo = 5 cmH₂O (10 min)

m. uso = 6h40'

} SB - 18 dias

⊗ - para auto 5 à 11 cmH₂O.

25/10/23 P = 6,5 cmH₂O

P95 = 9,6 cmH₂O

IAH = 9,3 l/h

m. de uso = 6h30'

Auto 5 à 11

- parelaria MMSS/MMII

- p

18/12 P = 7,0 cmH₂O

23 IAH = 9,8 l/h

m. de uso = 6h13'

fuga = 7,3 l/min.

fua

06/08 P = 8,3 cmH₂O

25 IAH = 7,6 l/h

m. de uso = 6h22'

fuga = 5,3 l/min

fua

Nome: GUILHERMESOARES CARDOSO DA CUNHA
Data de Nascimento: 17-12-1970
IMC: 28,73
Sexo: Masculino
Data do exame: 25-05-2022

Peso: 84 kg
Altura: 1,71 m
Médico: DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU
MACEDO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-05-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 574,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 75,0 e 105,0 minutos. O tempo total de sono foi de 458,0, eficiência de 79,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 72,3%; estágio N3: 4,7%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 46,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 75,6/hora, sendo elas 112 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 5 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 73%, permanecendo 10,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 75 bpm e NREM de 46 - 70 bpm.

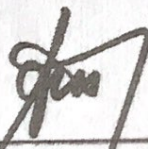
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 75,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=73%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono

Mecânico de vôo - Documento
- perola de disposição
- causa w p1 e exercício
- falta de disposição
- acorola cansado.

* ingestão bebida alcoólica
- HAS
- Colesterol
- edema de mmII

Café: 7:30
Almoço: 12
Lanche: cafézinho
Jantar: lanche

Dorme: 22:30
Acorda: 4:00.
ai cochila +
levanta 7h.

nasal a respiração, n tem obstru
ção nasal